

印度养老保障实践及对我国启示

杨 哲,马建宇

(安徽工业大学公共管理与法学院,安徽 马鞍山 243002)

摘要:作为与我国同为人口大国和农业大国的印度,面对人口老龄化加速演进的挑战,逐步构建起以职工公积金计划、全国老年养老金计划、全国养老金制度为核心的多层次养老保障体系,形成了政府主导、社会资本参与和志愿组织补充的多元协同实践模式。该国在养老保障覆盖范围拓展、城乡融合推进等方面积累了有益经验,但同时也暴露出制度碎片化突出、公平性失衡、基金管理专业性水平不足、传统养老观念固化等现实问题。鉴于中印两国在人口结构特征、城乡二元格局、孝老文化传统及家庭养老功能变迁等方面的相似性,印度的养老保障实践为我国提供了重要的比较视角与借鉴价值。我国可通过统筹制度顶层设计破解碎片化困境、坚守公平普惠导向扩大精准覆盖、激活市场活力构建多元协同保障格局、强化技术赋能与专业人才支撑提升养老服务质量,为应对重度老龄化挑战、完善养老保障体系提供系统性优化路径。

关键词:养老保障;印度;制度实践

中图分类号: C913.6

文献标志码: A

文章编号: 2097-7271(2026)01-0099-14

DOI:10.16161/j.issn.2097-7271.2026.01.010

人口老龄化无疑会造成各国的福利开支增加及财务负担加剧,其中公共养老保障支出占比最大,其次是医疗保障支出。若未能妥善解决老龄化带来的成本问题,可能引发类似2009年末希腊、意大利、西班牙等国遭遇的欧债危机。截至2024年5月,印度人口已超14.28亿,预计到2050年,该国60岁及以上人口将占

总人口的18.3%^[1]。老龄人口的快速增长和经济全球化,催生了庞大的养老保障市场,但同样面临人口转型期的潜在风险,加之出于增强财力与缩减赤字的需要,其政府通过逐步完善法规政策,着力解决养老制度缺乏顶层设计、“碎片化”严重及保障水平偏低等问题。

21世纪我国进入老龄化社会,且人口

[收稿日期]2025-12-11

[基金项目]2025年度安徽省中青年教师培养行动学科(专业)带头人培育项目(项目编号:DTR2025011);安徽省高等学校科学研究(人文社会科学)重大项目(项目编号:2024AH040289);安徽省中青年教师培养行动学科(专业)带头人培育项目(项目编号:DTR2025011);安徽省教育厅科学研究特需专项项目(项目编号:2025AHGXSK50113)。

[作者简介]杨哲(1981—),男,安徽庐江人,博士,安徽工业大学公共管理与法学院教授,研究方向为技术社会学;马建宇(2002—),男,安徽滁州人,安徽工业大学公共管理与法学院在读硕士研究生,研究方向为社会保障。

老龄化程度持续加深。国家统计局公布的第七次全国人口普查数据显示,2020年我国60岁及以上人口占比18.70%,65岁及以上人口占比13.50%,这意味着我国即将进入重度老龄化社会。同为农业大国的印度,同样面临地区发展不平衡和城乡二元化的困境。在历史文化上,两国传统文化均强调孝老敬老,但同样面临家庭养老功能的衰弱与代际沟通的减少等问题^[2]。因此,研究印度养老保障实践、梳理其发展脉络,对完善和创新我国养老保障具有重要的意义,可为我国养老保障发展提供借鉴,对加快推进我国养老保障制度建设与改革亦具有理论和现实价值。

一、文献回顾

国内外学界围绕印度养老保障实践的研究已经形成多维度脉络,核心聚焦于养老保障制度转型、养老保障政策效果、养老保障制度特征三大议题。既有研究梳理了从殖民时期到21世纪的印度养老保障制度的演进逻辑,同时对其实施效果、覆盖范围及管理效果等方面展开了实证分析,但仍存在对养老保障多计划间协同效应、新旧政策动态变化及借鉴价值挖掘不足的缺口,因此文章聚焦印度养老保障的时间特征,提炼其实践经验,归纳出对我国养老保障制度的启示。

(一)19世纪至21世纪印度养老保障实践演进研究

学界普遍认为,印度养老保障制度的演进是人口结构转型、经济体制改革与公民实际需求共同作用的结果,在21世纪初

进入多养老金计划协同运作的关键转型期。秦永红等指出,19世纪殖民战争后印度建立的养老保障制度因碎片化、覆盖有限等问题,在经济全球化与人口老龄化冲击下亟须改革^[3]。左停等同样发现,印度自20世纪60年代推进的农村养老计划,因城乡二元结构与种姓差异,效果未达预期,直至21世纪政策调整后才逐步改善^[4]。而21世纪后的养老实践研究成为研究重点:赵忻怡等通过系统分析2004年具有里程碑意义的全国养老金制度,认为其促使养老保障从仅覆盖公务员扩展至全民自愿参与,该改革标志着印度养老保障进入“缴费型与非缴费型并行”的新阶段^[5];杨国伟等则指出这一转型契合其非组织部门占比高的国情,同时是南亚地区补缺型非正式保障体制向多层次保障体制的突破典范。Narayana基于国民转移账户框架,指出全国老年养老金计划按年龄分层调整补贴标准的改革措施,是对老年贫困差异化需求的回应^[6];后续推出的阿塔尔养老金计划,被Rooj等视为针对非正式部门养老保障的关键创新^[7]。

(二)核心养老保障计划的实施效果研究

学界针对印度养老保障三大核心计划,即全国老年养老金计划、阿塔尔养老金计划、国家养老金制度的研究,既肯定其实践成效,更聚焦实施过程中所突出的具体问题。首先是英迪拉·甘地全国老年养老金计划,其作为非缴费型核心计划,减贫效应与覆盖缺口是研究焦点。Lakshmanasamy基于数千名老年人样本,

通过实证研究发现全国老年养老金计划使老年人贫困率略微下降,且补贴未与通胀挂钩,仅小部分贫困老人充分受益^[8];Narayana 进一步证实该计划以不足 0.2% 的财政支出占比,却显著降低了老年群体的生命周期赤字,但覆盖范围存在农村遗漏与年龄歧视,80 岁以上高龄老人受益率仅 32.58%^[9]。Asri 同样指出该计划靶向机制存在改进框架,持有贫困线以下证明卡是受益前提,这导致部分无卡贫困老人被排除在外。其次是阿塔尔养老金计划,针对该计划的研究集中于覆盖效果与协同效应。Rooj 等利用半参数回归分析发现,其对非正式部门工人的正规退休储蓄具有挤入效应,但该计划 2017 年参保率不足 2%,是由自愿参与模式所导致的;国际劳工组织 2024 年的工作文件进一步指出,印度农村地区由于信任不足与数字鸿沟,导致阿塔尔养老金计划在非组织部门的覆盖不足。最后是国家养老金制度,其研究重点是绩效管理。Murari 通过夏普比率等指标评估发现,其基金绩效存在管理人差异,住房开发金融公司在权益类资产投资中表现突出,但政府债券资产占比过高制约了长期收益^[10];Das 补充,国家养老金制度监管碎片化导致基金运营效率不足,且年化收益率低于市场平均水平^[11]。

(三) 养老保障制度公平性与可持续性研究

学者们普遍较为关注印度养老保障在城乡、性别、组织间的公平性缺口,21 世纪的研究更加强调公平性的政策方向。

左停等指出,印度农村老年人口占比高,但养老保障长期向城市倾斜,尽管全国老年养老金计划与阿塔尔养老金计划试图弥补,但城乡受益仍然差异较大^[12];Mehta 等发现,养老保障受益的性别差异同样显著,女性在国家养老金制度的参与率比男性低大约 20%,核心原因是女性的养老金缴纳意识薄弱与非正式就业比例高^[13]。正式组织间与非正式组织间的差距同样巨大,83% 的劳动力集中于非正式组织,该群体因收入不稳定、参保流程复杂等因素,养老保障覆盖率仅 25%^[14]。围绕印度养老基金的投资效率与可持续性,学界形成了两类主流观点:一类聚焦基金运营问题,杨国伟等指出,职工公积金组织作为印度国内最大非银行金融机构,因缺乏专职投资部门与独立专家决策,资产多元化不足,投资回报率长期偏低;另一类则关注财政可持续性,Narayana 通过国民转移账户框架指出,提升老年人经济安全水平,可以实施全国老年养老金计划与贫困线挂钩的普遍化改革,以 0.2% 的财政支出换取养老金较强的可持续性。

现有研究已较为全面地梳理了印度养老保障的制度转型、核心计划效果、公平性挑战与可持续性问题,尤其聚焦 21 世纪以来的政策创新与实践成效,为文章提供了坚实的理论基础。但仍存在三点不足:一是研究多聚焦单一计划或单一维度,缺乏对印度养老保障体系“多支柱协同”特征的系统整合;二是部分研究对 2020 年后的新近动态覆盖不足;三是现有研究多侧重其本土问题分析,对我国养老

保障的借鉴价值挖掘不够。

二、印度养老保障的实践探索

从印度养老保障制度体系架构来看,该国已经初步构建了一套具有自身特色的养老保障体系。在学术界这一制度被称为“老年安排”或“社会保障”,根据社会保障理论,该体系由三大支柱构成。

第一支柱为国家养老金,其资金主要源于税收,大部分无需劳动者额外缴纳,因此被视为“社会养老金”。2007年11月,政府实施了“英迪拉·甘地老年养老金计划”,主要面向65岁以上、生活在贫困线以下的老年人群。据报告,此计划已覆盖全国超过1千万的人口,受益人每月可领取200卢比的生活补贴性养老金。此外,各邦还增加了等额补贴,符合条件的老年人每月总计可领取400卢比的养老金^[15]。第二支柱是在职劳动者的储蓄计划,由雇员与雇主共同出资,遵循中央政府制订的雇员强制性退休方案。该方案覆盖广泛民众,操作便捷,民众可通过乡村邮政服务或银行轻松加入。全国养老金制度便是此类保障政策的典型案例。第三支柱本质上属于个体储蓄,专门面向非正规就业劳动者,主要由小微金融机构负责管理和实施。1952年,该国出台《职工公积金与相关规定法》,仅为有组织部门的劳动者提供养老金;1995年推出国家社会救助项目,通过再分配手段,以现金的方式资助贫困老年人;2004年颁布国家养老金计划,此后几年内,养老金覆盖范围实现突破,从最初的全体公务员扩大至

企业雇员和非组织部门的劳动者,目前已经初步形成了具有现代意义的多层次的社会养老保障制度^[16]。

(一)职工公积金组织计划:养老保障的初始形态

印度早在英国殖民时期就开始探索职工公积金制度,但当时的养老保障仅能覆盖英国统治阶层以及少数为殖民政府工作的本地人。刚独立时,政府并未面临严重老龄化挑战,年轻人口比例相对较高,养老问题并未成为社会的主要矛盾;加之发展政治和经济任务的紧迫,且传统农业结构未遭受显著破坏,其政府当时并未将重心放在解决民众养老问题上。因此,该国仅在1952年简单颁布《职工公积金与相关规定法》,并在后续历史进程中制定了三大职工养老的相关计划,即1952年“职工公积金计划”、1976年“职工储蓄保险计划”和1995年“职工养老金计划”^[17]。

1. 职工公积金计划

职工公积金计划成立于1952年,目标对象是雇员人数超过20人的公司或者实体企业,包括工厂、商店、办公室等,以及由该国中央政府通知的需要缴纳的实体——即使公司不满20人,仍有可能需要缴纳。该计划本质上旨在帮助职工建立退休资金库,由雇员公积金组织负责管理,主要承担制定公积金政策、监督公积金的缴纳和提取、管理公积金账户等职责。公积金账户内的资金主要用于保障职工的退休生活,在满足特定条件的情况下同样可以用于支付房屋贷款、医疗费用

等支出。账户资金会产生一定的利息,利率与投资政策由政府和职工公积金计划的中央董事会共同决定。缴费标准随经济阶段调整,目前保金由雇主和雇员共同承担:雇主缴纳工资的 3.67%,雇员缴纳工资的 12%,缴费计入雇员个人账户;此外,雇主还需要缴纳工资 1.1% 的管理费,部分豁免缴纳管理费的企业需要缴纳 0.18% 的监察费。

2. 职工储蓄保险计划

职工储蓄保险计划的实施始于 1976 年,是一项特色鲜明、目标明确的保险制度,旨在为雇主和雇员提供额外的经济保障,尤其针对特殊情况,例如雇员不幸死亡或者身体遭受永久伤残时。在该计划中,雇主要为员工支付一定比例的保险费,根据劳动法规定,雇主需缴纳等同员工工资的 0.5% 的职工储蓄保险计划的保险费,此外还需支付额外 0.01% 的管理费,部分豁免缴纳管理费的企业需要缴纳 0.005% 的监察费,具体金额根据员工数量

而定。上述费用均由雇主承担,员工无需额外支付。死亡职工的家庭可以在以下两个方案中任选其一:(1)根据之前 12 个月中职工公积金账户中资金平均额计算;(2)按照已故员工去世前 12 个月每月 6500 卢比工资计算,最高发放金额不超过 13 万卢比。

3. 职工养老金计划

职工养老金计划是中央政府为了取代 1976 年实施的“雇员家庭养老金计划”而出台的,属于待遇确定型养老保险制度。1995 年改革实施前入职的雇员,可自主决定是否加入雇员家庭养老金计划;1995 年及以后入职,且月薪低于 5000 卢比的员工则被强制加入此计划。保费由雇主与政府分摊,其中雇主需缴纳工资的 8.33%,政府补贴工资的 1.16%,员工无需负担(图 1)。职工养老金计划的核心目的是为参保人退休后提供经济支持,根据相关规定,参保人在退休后可以领取固定年限的养老金,或选择一次性支取^[18]。

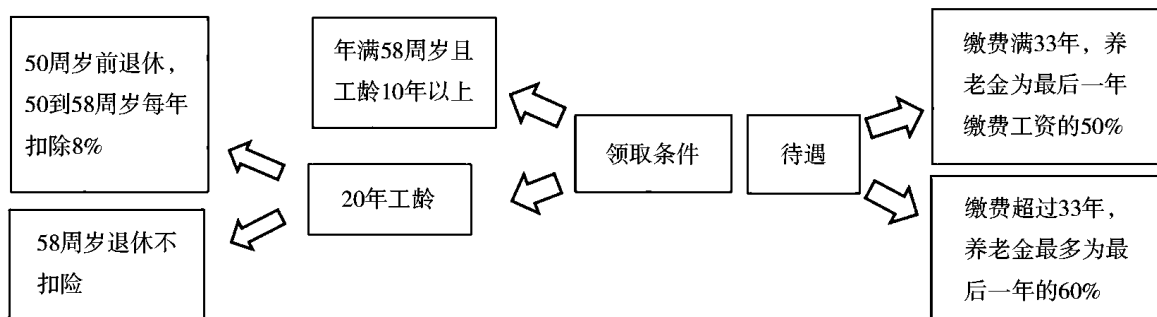


图 1 职工养老金计划缴费条件和待遇

概括而言,在职工公积金组织体系内,退休的员工可一次性提取职工公积金计划中职工公积金;或选择每月从职工养

老金计划中接收养老金;若不幸去世,其指定受益人可从职工储蓄保险计划中领取一次性福利金^[19]。

表1 职工公积金计划、职工储蓄保险计划及职工养老金计划的缴费情况

	缴费账户(%)			管理账户(%)		合计 (%)
	公积金	保险储蓄	养老金	公积金	保险储蓄	
雇主	3.67	0.5	8.33	1.10	0.01	13.61
职工	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
政府	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	1.16
合计	15.67	0.5	9.49	1.10	0.01	26.77

注:数据来源于印度《职工公积金与相关规定法》、1995年职工养老金计划官方实施细则

(二)全国老年养老金计划:养老保障的补充

随着经济和社会改革的深入推进,农村地区的经济与社会面貌经历了显著的转变。这一变化引发农村社会家庭结构的调整,年轻一代逐渐向城市迁移,依托于传统宗法观念的家庭养老功能日渐弱化。在此背景下,传统家庭已难以充分承担起养老责任,农村老年人的养老需求日益难以得到满足。为此,印度政府推行了

“英迪拉·甘地全国老年养老金计划”,该计划是全国社会援助计划的重要组成部分之一(表2)。通过实施这一计划,政府在全国实现了两项政策目标:一是将社会援助计划与全国的减贫目标相结合,二是将该政策与低保制度建设相衔接,尤其是通过此计划,使该国社会政策与养老、贫困人口医保及其他福利政策有效融合,较好地发挥了稳定社会发展的功效^[20]。

表2 全国社会援助计划的五个方案

	援助对象	领取福利
全国老年养老金计划	60岁以上、收入贫困线以下	60—79岁每月200卢比,80岁及以上每月500卢比
全国寡妇养老金计划	40岁以上、收入贫困线以下并在政府登记的丧偶女性	40—79岁每月300卢比,80岁及以上每月500卢比
全国残疾人养老金计划	18岁以上、残疾程度80%并且收入在贫困线以下	18—79岁每月300卢比,80岁及以上每月500卢比
安娜普尔纳计划	65岁以上、收入或家庭成员的资助不能满足基本生活需求且没有被全国老年养老金计划覆盖的	每月10公斤粮食
国家家庭受益计划	18—59岁、家庭主要劳动力患有癌症或已经死亡的居民	一次性定额现金补助,金额为20000卢比

注:数据来源于印度《职工公积金与相关规定法》、1976年职工储蓄保险计划政策、1995年职工养老金计划政策

1995 年之前,印度老年社会保障制度主要由地方政府进行管理,在全国老年养老金制度建设方面,地方政府结合实际情

况提供福利,资金主要由中央政府通过农村发展计划拨付。尽管此计划的实际福利水平对真正需要帮扶的老人稍显不足,但受益范围总体上呈扩大趋势^[21](表 3)。

表 3 全国老年养老金计划 1995—2000 财年受益情况

财年	1995—1996	1996—1997	1997—1998	1998—1999	1999—2000
受益人占比(%)	55.06	89.21	95.74	90.31	86.26

注:数据来源于印度农村发展部全国老年养老金计划实施统计数据

从具体实施情况来看,该计划仍存在一些问题。首先,制度漏洞导致资金公平性不足,确定资金接受方存在困难,且存在明显贪污腐败现象。调研数据表明,部分家庭中,即便多位成员符合接受援助资格,但通常只有一人能够资助;加之多个部门的参与资金分配,职责划分模糊,进一步加剧此问题。其次,早期出生登记管理体系落后,许多儿童出生时未能正式登记,官方难以确定其确切的出生日期,后续补办登记手续程序复杂、耗时耗力。再次,福利水平备受民众争议,补贴数额微薄,每月资金仅够老年人购买平均粮食消费量的食物,大约 8 千克小麦、8 千克大米以及 0.4 千克白糖。理想的福利金应当有足够的购买力,除满足基本的粮食需求外,还能剩余资金支付水电等生活开销。最后,管理效率不足,政策实施模式过于笼统,未充分考量精确性便进行大规模的政策覆盖,从而致使人力、物力以及资金资源的大量浪费^[22]。

(三) 全国养老金制度:养老保障的进阶

1992 至 1997 年的第八个五年计划期

间,印度迈入了经济体制改革的新阶段,自由化改革和国家福利保障制度构建成为改革核心内容。在此期间,政府首次明确承担养老保障的国家责任,同时为应对即将到来的老龄化风险,确立了具有里程碑意义的全国养老金制度。该制度成立于 2004 年 1 月 1 日,是在当时现行的养老金制度基础上建立的有限缴费养老金制度,最初仅面向新入职的公务员;随着政策的发展和公民诉求,自 2009 年 5 月 1 日起,所有公民均可自愿参与,其长期目标是为全体国民提供基本的养老保障。

1. 全国养老金制度的目标人群

根据覆盖人群范围,全国养老金制度可以划分为四种类型:公务员全国养老金制度(政府雇员方案)、全民全国养老金制度(全民方案)、企业全国养老金制度(企业方案)及简化全国养老金制度(精简版)。2004 年 1 月 1 日起,新加入中央政府的公务员被强制要求参加公务员全国养老金制度。同时,已实施此制度的各邦,其新入职的邦政府公务员同样需强制参与^[23]。

2010 年 7 月 22 日起实施的简化全国

养老金制度,专为自愿参加的非正规就业者和其他社会弱势群体设计,旨在通过简化的流程,让更多人能够轻松地参与该制度(表4)。

表4 四种全国养老金的颁布时间及目标人群

	公务员全国养老金	全民全国养老金	企业全国养老金	简化全国养老金
颁布时间	2004. 1. 1	2009. 5. 1	—	2010. 7. 22
目标人群	新加入中央政府的公务员(军队除外)	18—55岁的自愿缴费的全体公民	18—60岁的自愿参加的雇员	非正规就业者或社会弱势群体

注:数据来源于全国养老金制度官方政策文本

2. 全国养老金制度的投资方案

全国养老金计划提供两种投资选项。首先是所谓的主动方案,涉及个人基金的投资,包含E级(股权)、C级(公司债券)以及G级(政府债券)资产;其次,自动方案,即基于生命周期的资金投资策略^[24]。

方案一:个体养老基金。在该方案下,养老金持有者有权自主选择E、G、C三种投资目标中进行投资,其中E级资产和G级资产的投资比例无严格限制,但是对于E级资产,其投资额不得超过资产总额的50%。此外,所有的投资决策都必须符合养老金管理与发展理事会规定的其他投资规定。资金投资将由养老金管理与发展理事会指定的6家基金管理公司执行。有关账户资金的再平衡问题,根据养老金管理与发展理事会的规定,针对主动投资策略,账户资金的再平衡在总股权投资占养老金资产的50%的上限下进行。一旦

投资额度超越该界限,必须在养老金持有人的下一次生日时进行资金再平衡操作。

方案二:自动化策略。对于那些由于知识局限的养老金参与者,全国养老金制度提供了自动化选择方案。参与者的养老金资金将被投资于生命周期基金中,并且投资组合将按照预设的比例进行资金调配。若养老金参与者自18岁起加入全国养老金制度,则其投资将依照50%、30%、20%的比例分别配置于E级、C级、G级资产之中。这种资金分配策略将持续执行,直至参与者年满35岁。从养老金领取者年龄达到36岁起,E级和C级资产的占比将逐年递减,而G级资产的占比则将逐年增加。待养老金领取者年龄超过55岁时,资产配置比例将稳定为E级资产占10%、C级资产占10%、G级资产占80%^[25](表5)。

表5 生命周期基金年龄—资产对照表

年 龄	资产等级(%)			年 龄	资产等级(%)		
	E 级	C 级	G 级		E 级	C 级	G 级
35 岁以前	50	30	20	46 岁	28	19	53
36 岁	48	29	23	47 岁	26	18	56
37 岁	46	28	26	48 岁	24	17	59
38 岁	44	27	29	49 岁	22	16	62
39 岁	42	26	32	50 岁	20	15	65
40 岁	40	25	35	51 岁	18	14	68
41 岁	38	24	38	52 岁	16	13	71
42 岁	36	23	41	53 岁	14	12	74
43 岁	34	22	44	54 岁	12	11	77
44 岁	32	21	47	55 岁	10	10	80
45 岁	30	20	50	—	—	—	—

注:数据来源于印度养老金管理与发展理事会投资规则、全国养老金制度投资方案细则

三、养老保障实践的成功经验与不足

(一) 养老保障实践的成功经验

1. 政府推动建立了具有现代意义的养老保障制度

印度政府在经济发展相对落后,社会矛盾突出的背景下,敏锐察觉到养老问题对于社会和谐的重要性,意识到完善的养老服务制度必须具备明确的法律依据,因此在建国初期便颁布《雇员长期基金及各项规定法》。随后为拓宽养老保障的覆盖范围,将服务对象从有组织部门逐步扩展至非组织部门的员工,并着力提升养老保障的质量与效率,设立了由职工和雇员共同缴纳的公积金计划。同时政府通过制定一系列政策,鼓励社会资本投入养老服务领域,并设立专门监督管理机构实施有

效监管,避免放任自流和不作为。上述要素的整合,使该国最终构建出了具有现代特征的养老保障制度。

2. 社会资本助力下形成多元化的养老保障模式

随着印度社会经济的持续进步与人口老龄化加剧,尽管“家庭养老”仍占据主导地位,但养老服务市场规模不断扩大。社会养老企业针对不同群体需求设计出差异化的养老服务:对生活自理能力较强的老年人,独立生活设施提供自由便捷的环境,使其保持个体独立性的同时尽享晚年生活乐趣;对需要一定照护的老年人,辅助生活设施提供细致周到的服务,涵盖日常生活照料与基础医疗护理;社区护理服务则将养老服务延伸至社区层面,通过组织各类活动、提供多元服务,增强老年

人的社区归属感,同时为其提供更便捷的日常生活支持。

3. 志愿组织和自助团体参与养老保障实践

随着城市化进程加速和人口老龄化趋势凸显,该国半城市及农村地区老年人面临更多生活挑战,志愿组织和自助团体应运而生,填补相关服务空白。这些组织通常由一群热心公益、志同道合的志愿者组成,通过开展各类活动与项目,为老年人提供非医疗护理服务,涵盖日常生活照料、健康监测、康复锻炼等,保障老年人基本生活需求。此外,这些组织还关注老年人社交与心理需求。同时积极倡导尊老敬老的社会风尚,通过举办各类宣传活动、公益讲座,提高公众对老年人权益的关注和认知,鼓励年轻人积极参与养老服务,传递爱心与温暖。

4. 逐渐实现养老保障的城乡融合

自由独立的初期阶段,政府的养老保障措施并未普及至全体公民,仅覆盖公务员及部分有组织部门人员,养老保障的覆盖面狭窄、受益群体有限。随着城市化进程的推进,养老保障的范围逐步拓展,城市老年人成为受益者,城乡差异随之显现,农村地区老年人的基本生活保障问题并未得到解决。但随着养老保障制度的持续发展和完善,农村老年人的处境得到了改善,逐步获得应有的养老保障——“英迪拉·甘地全国老年养老金计划”“全国养老金制度”的实施,标志着养老保障制度的进一步完善,农村居民的权益得到更好的保障。

(二) 养老保障实践的不足

1. 养老保障制度不健全且碎片化

印度的养老保障制度尚未实现全面覆盖,大量老年人无法享受到应有的保障。城乡、行业差距显著,导致养老保障制度在不同地区、行业中呈现出差异化面貌,许多老年人被排除在制度之外,缺乏必要的养老支持。政府虽然推行各类养老保障政策与条例,但彼此之间相互独立,缺乏协同性;养老保障基金运营缺乏活力,由于缺乏有效的监管机制与科学的投资策略,基金往往难以实现较高的投资回报率,甚至可能出现亏损,既影响了基金的长期可持续性,同时削弱了其为老年人提供基本生活保障的能力。此外,制度的运行缺乏完善的监督管理机构,易滋生贪污腐败、滥用职权等现象。

2. 养老保障覆盖率低且公平性不足

养老保障系统的覆盖面最初局限于公务员和大多数有组织部门的雇员,后逐步向非组织部门的劳动者拓展。这一调整主要源于国家大多数的劳动力都集中在非组织部门。虽然政府推出了各类养老服务计划以及社会救济补贴计划,试图为更广泛的人群提供支持和保障,但这些计划的实际覆盖率相对较低,尤其是在非组织部门和农村地区,贫困老人往往难以从中受益。即便部分老年人被纳入保障范围内,补贴标准同样偏低。这一现状暴露出该国养老保障体系在扩大覆盖范围、提高补贴效益方面亟须采取更有效的措施。此外,养老保障公平性差,在职业、城乡、性别等方面差异明显。

3. 社保基金管理专业性欠缺且投资渠道有限

职工公积金组织占据了印度国内生产总值约6%,因此被誉为最大的非银行金融机构,尽管其规模庞大,该组织的管理架构却并未遵循现代企业治理的要求:中央董事会成员共36人,构成复杂,包括15名中央与地方官员、10名雇主代表、10名职工代表,未纳入任何政府之外的独立专家,限制了决策的专业性。尽管该组织拥有高达2万名员工,但未设立专职的投资部门,这显然是对其投资能力的一种限制,难以实施有效的资产多元化策略,这意味着投资可能过于集中,增加了风险。由于这种投资策略的限制,使得基金无法进行广泛的资产分散投资,对其投资效果和收益进行了限制。

4. 养老观念较传统且受文化差异制约

印度的养老观念和文化差异对养老服务的发展产生显著影响。传统观念体系中,子女被赋予承担父母晚年生活的主要责任,对父母的照料和赡养被视为子女应尽的义务。这种深植于社会的养老观念,使得老年人普遍倾向于家庭养老,而非选择养老机构或社区养老,他们通常将家庭视为最主要的依靠,习惯于在熟悉的环境中度过晚年,享受家庭成员的关爱和陪伴。因此,尽管养老服务的数量和质量均有提升,但大多数老年人依旧对机构养老或社区养老存在疑虑,表现出抵触情绪,担心社会关系变动会削弱其与家庭成员之间的联系和情感纽带。对于子女而言,老年人被认为是家庭的宝贵财富,许多年

轻人并不愿老年人远离家庭,独自入住养老院。

四、印度养老服务实践对我国的启示

印度养老保障实践人在制度构建、多元主体参与、覆盖范围拓展等方面的成功探索,以及在制度整合、保障公平性、养老基金管理等方面暴露出的问题,为我国应对重度老龄化与完善养老保障体系提供了针对性借鉴。结合我国城乡二元分割、灵活就业群体庞大、养老服务供需失衡等现实国情,提出以下优化路径:

(一) 统筹养老保障制度设计,破解“碎片化”困境

印度养老保障体系因缺乏协同机制,导致城乡、行业保障差异显著,制度运行效率不足,而其逐步推进城乡融合的实践则证明了统筹规划的重要性。针对我国养老保障存在的城乡二元分割、不同群体保障福利割裂的问题,需从三方面发力:一是建立全国统一的养老保障统筹机制,打破行政区域与就业类型的壁垒,将城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、灵活就业人员养老保险等制度纳入统一框架,明确各级政府的财政责任与管理权限,实现管理的衔接;二是优化制度结构,借鉴印度“三大支柱”体系经验,强化基本养老保险的普惠性,提升企业年金、职业年金的覆盖面,激活个人养老金的补充功能,针对不同收入群体设计差异化参与方案;三是搭建全国统一的养老保障信息平台,整合参保、缴费、待遇领取、资格认证等全流程数据,为制度统筹提供技术支撑,避

免出现类似印度因管理分散导致的资源浪费与贪污腐败隐患。

(二) 坚守公平普惠导向, 扩大保障覆盖的精准性

印度养老保障从仅覆盖公务员逐步拓展至全民的历程, 包括其在农村、非组织部门、女性群体中覆盖率不足的教训, 为我国优化保障范围提供了重要参考。我国需以兜底普惠结合精准对接为原则, 破解覆盖不均问题。一是聚焦农村居民、灵活就业人员、低收入群体等薄弱环节, 简化参保流程, 同时针对农民、农民工等群体设计弹性缴费档次, 允许跨年度补缴、断缴续接, 避免因收入不稳定或流程复杂被排除在制度之外; 二是建立动态补贴机制, 借鉴全国老年养老金计划与贫困线挂钩的思路, 对低收入、重度残疾、失独家庭等特殊老年群体, 采取财政补贴养老缴费, 提高补贴标准并与物价上涨指数联动, 确保保障力度不缩水; 三是关注性别公平, 针对女性就业不稳定、参保年限短等问题, 探索对生育女性给予参保年限补贴、延迟退休女性适当提高待遇等政策, 缩小养老保障中的性别差距, 弥补女性参保率上的短板。

(三) 放宽准入原则激活市场活力, 构建多元协同的保障格局

引入社会资本、志愿组织参与养老服务领域, 并通过专门机构管理养老金的实践, 证明了多元主体参与的有效性, 而基金运营效率低、投资渠道窄的问题则警示我国需注重“开放与监管并重”。我国应从三方面构建多元协同体系: 一是放宽市

场准入原则, 鼓励民营企业、社会组织、公益力量参与养老服务领域, 借鉴差异化养老服务提供模式, 满足不同老年群体的需求; 二是规范私人养老金市场发展, 引入专业化养老基金管理机构, 借鉴全国养老金制度的投资策略, 允许基金在风险可控前提下开展多元化投资, 同时设立专门的监管机构, 强化对基金运营的全程监管, 避免管理专业性不足、投资集中的风险; 三是培育志愿组织, 鼓励社区成立养老志愿服务队、老年人互帮互助小组, 提供生活照料、情感陪伴、健康咨询等非医疗服务, 同时通过税费减免、表彰激励等政策, 引导社会力量参与养老公益事业, 填补公共服务的空白。

(四) 强化数字技术赋能与人才支撑, 提升养老服务质量

印度利用数字技术开展健康监测、远程医疗的创新实践, 及其养老服务人才短缺、观念传统的问题, 为我国提升养老服务质量提供了双重启示。我国需以技术配合人才为引擎, 破解服务供给不足、质量不高的难题。一是推进养老服务数字化转型, 借鉴数字技术赋能经验, 在居家养老中推广数字智能家居, 在机构养老中引入智慧护理、健康管理系统, 实现老年健康状况实时追踪与服务需求快速响应; 二是加强专业人才培养, 在高等院校、职业技术学院设立养老服务相关专业, 优化课程设置, 强化实践教学, 与养老机构建立校企合作机制, 保障人才供给; 同时建立健全养老服务人员薪酬保障体系, 提升行业吸引力; 三是引导养老观念更新,

通过媒体宣传、社区教育等方式,普及社区、机构养老多元模式,打破传统养老观念的束缚,缓解因观念保守导致的服务资源闲置问题。

[参考文献]

- [1] 杨宜勇,韩鑫彤.提高我国养老服务质量的国际经验及政策建议[J].经济与管理评论,2020,36(1):5-14.
- [2] 何晖,芦艳子.创新与治理:印度社会养老金制度的改革与前瞻[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2020,44(2):33-41.
- [3] 秦永红,张伟.印度社会保障制度改革及其对我国的启示[J].南亚研究季刊,2011(2):48-55.
- [4] 左倬,李世雄,武晋.国际社会保障减贫:模式比较与政策启示[J].国外社会科学,2020(6):35-45.
- [5] 赵忻怡,杨伟国,李丽林,等.印度养老保障制度及其启示[J].南亚研究季刊,2021(4):79-98.
- [6] Narayana M R. Improving Economic Security for Older Persons By Public Pension Schemes:Evidence From National Transfer Accounts for India[J]. Journal of Social and Economic Development,2023: 1-32.
- [7] Roj D, Sengupta R. Contributory Pension Scheme and Formal Retirement Savings: Is There a Trade-off - evidence From India's Atal Pension Yojna Using Copula Regression Methodology [J]. Review of Economics of the Household, 2025, 23(1): 225-244.
- [8] Lakshmanasamy T. The Effect of Central Financial Transfers on Tax Efforts of State in India: A Panel Data Analysis[J]. Journal of International Money, Banking and Finance, 2022, 3(1): 51-68.
- [9] Murari K. Risk-adjusted Performance Evaluation of Pension Fund Managers under Social Security Schemes (National Pension System) of India[J]. Journal of Sustainable Finance & Investment, 2022, 12(4): 1217-1231.
- [10] Das S, Mukhopadhyay B, Mukhopadhyay S. Understanding Frailty: Perspectives and Experiences of Rural Older Adults in India[J]. The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2024, 79(8): gbae096.

- [11] Mehta A K, Chowdhury S. Gender Inequalities in Health and Care[J]. India Social Development Report 2023, 2024: 179.
- [12] Kshatri J S, Shenkin S, Mercer S, et al. Improving Health Outcomes Among Older Adults In India: Effectiveness and Implementability of a Novel Comprehensive Geriatric Assessment Based Intervention[J]. Welcome Open Research, 2024(8): 414.
- [13] 郑秉文.主权养老基金的比较分析与发展趋势——中国建立外汇型主权养老基金的窗口期[J].国际经济评论,2019(3):9-30.
- [14] Vaishnav L M, Joshi S H, Joshi A U, et al. The National Programme for Health Care of the Elderly: a Review of Its Achievements and Challenges in India [J]. Annals of Geriatric Medicine and Research, 2022, 26(3): 183.
- [15] 杨燕绥,妥宏武,杜天天.国家养老金体系及其体制机制建设[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2018,20(4):30-37,91.
- [16] Dey S, Nambiar D, Lakshmi J K, et al. Health of the Elderly in India: Challenges of Access and Affordability [J]. Aging in Asia: Findings From New and Emerging Data Initiatives, 2012, 371: 86.
- [17] Rajan S I, Balagopal G. Elderly Care in India Societal and State Responses[J]. Elderly Care, 2014.
- [18] Lakshmanasamy T. Social Assistance and Welfare in India: Propensity Score Matching Estimation of the Impact of Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme on Household Consumption[J]. Journal of Strategic Human Resource Management, 2022, 11(2): 9-17.
- [19] Roy P, Barua A. Labour Force Participation Among the Elderly in India: What Does the Latest Data show? [J]. International Journal of Social Economics, 2023, 50(4): 592-605.
- [20] Khan P K, Sen S, Mohanty S K. Pattern of Health Insurance Coverage and Reimbursement Among Elderly and Non-elderly in India [M]//Handbook of Aging, Health and Public Policy: Perspectives From Asia. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025: 1923-1940.

[21] Sarmah C. Social Welfare Programs For Elderly In the State of Assam, India [M]//Handbook of Aging, Health and Public Policy: Perspectives from Asia. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025: 1431 – 1443.

[22] 赫国胜, 柳如眉. 金砖五国人口老龄化、公共养老金

支出及其改革策略分析[J]. 经济体制改革, 2016(5): 56 – 61.

[23] 李亚军. 印度非缴费型养老金制度发展评述[J]. 南亚研究季刊, 2014(1): 71 – 75.

The Practices of India's Pension Security and Inspirations for China

YANG Zhe, MA Jianyu

(School of Public Management & Law, Anhui University of Technology, Maanshan, Anhui 243002, China)

Abstract: In the face of the challenge of aging population, India, a populous and agricultural country like China, has gradually established a multi – level pension security system centered on the Employees' Provident Fund, the National Old Age Pension Scheme, and the National Pension System. This has fostered a multi – stakeholder collaborative model led by the government, participated with social capital and supported from voluntary organizations. India has accumulated valuable experience in expanding pension coverage and promoting urban – rural integration. However, it has also exposed practical issues such as significant institutional fragmentation, fairness imbalances, insufficient professionalism in fund management, and entrenched traditional views on elderly care. Given the similarities between China and India in terms of demographic characteristics, urban – rural divide, filial piety culture, and the evolving role of family support for the elderly, India's pension security practices provide an important comparative perspective and reference for China. By coordinating top – level institutional design to address fragmentation, adhering to fairness and inclusiveness to expand targeted coverage, mobilizing market forces to build a diverse and collaborative security framework, and leveraging technology and professional expertise to improve elderly care services, China can develop systematic optimization strategies to tackle the challenges of severe population aging and enhance its pension security system.

Keywords: Elderly services; India; Institutional practice

[责任编辑:王雪炎]